PFLEGELABORBLOG · DOWNLOAD

Sturzprophylaxe-Praxispaket

Vorbeugen, erkennen, richtig handeln: vier Blätter zum Ausdrucken, passend zum Blogbeitrag „Sturzprophylaxe: Wie wir Stürzen vorbeugen und was nach einem Sturz zu tun ist“.

Inhalt

Blatt 1	**Risiko-Check**	Worauf wir achten
Blatt 2	**Wohnung-Check**	Gefahren erkennen, bevor etwas passiert
Blatt 3	**Ablaufkarte**	Nach einem Sturz: So gehe ich vor
Blatt 4	**Sturzprotokoll**	Jeden Sturz festhalten

So nutzt du das Paket
Blatt 1 und 2 füllst du gemeinsam mit der betroffenen Person aus. Blatt 3 hängst du dorthin, wo Hilfe schnell gebraucht wird. Blatt 4 legst du bereit, damit nach einem Sturz nichts vergessen wird. Jedes Blatt passt auf eine Seite und lässt sich einzeln drucken.

Wichtig: Dieses Blatt dient der Information und Bildung. Es ist kein geprüftes Messinstrument, keine Pflegeberatung im Sinne des § 7a SGB XI und ersetzt weder Erste-Hilfe-Kurs noch ärztliche oder pflegefachliche Beratung.

Steffen Vollmer · Azubi Pflegefachmann · 3. November 2026 · pflegelaborblog.de

BLATT 1 VON 4 · RISIKO-CHECK

Worauf wir achten

Eine Beobachtungshilfe für Angehörige, Azubis und Pflegende. Ein Kreuz bedeutet: darüber sprechen.

Für (Kürzel): _____ Datum: _____

Ausgefüllt von: _____

Personenbezogen

☐	In letzter Zeit gestürzt oder fast gestürzt (Beinahesturz)? Zwei oder mehr Stürze in 12 Monaten gelten in der Leitlinie als hohes Risiko.	D W
☐	Unsicher beim Stehen, Gehen oder Aufstehen (Gleichgewicht)?	D
☐	Schwindel oder Blutdruckabfall beim Aufstehen (orthostatische Hypotonie)?	D W
☐	Kurzzeitige Aussetzer oder Bewusstlosigkeit?	W
☐	Angst vor einem Sturz, traut sich weniger zu als früher?	D W
☐	Sehprobleme, Brille alt oder ungeeignet?	W
☐	Schmerzen oder Probleme an den Füßen?	W
☐	Schuhe ohne festen Halt, offene Hausschuhe oder barfuß unterwegs?	W P
☐	Nachlassende Kraft in den Beinen, schnelle Erschöpfung?	P
☐	Drängender Toilettengang, Eile auf dem Weg zur Toilette?	P

Medikamente

☐	Neue Medikamente oder geänderte Dosis in den letzten Wochen?	P
☐	Beruhigungs-, Schlaf- oder blutdrucksenkende Mittel im Einsatz?	P
☐	Wurden die Medikamente von Ärztin, Arzt oder Apotheke auf Sturzrisiko überprüft?	W

Umgebung

☐	Stolperfallen, schlechtes Licht oder rutschige Böden? Dazu Blatt 2 ausfüllen.	W P
☐	Hilfsmittel (Rollator, Stock) vorhanden, passend eingestellt und in Reichweite?	P

Was jetzt? Mindestens ein Kreuz heißt nicht, dass ein Sturz kommt. Es heißt: Sprich mit der Pflegefachkraft, der Hausärztin oder dem Hausarzt. Der Expertenstandard verlangt, das Risiko bei Veränderungen der Pflegesituation, nach einem Sturz und in festgelegten Abständen neu einzuschätzen (DNQP, 2022, S. 23). Das Blatt zählt keine Punkte.

Information und Bildung, kein geprüftes Messinstrument, keine Pflegeberatung (§ 7a SGB XI), kein Ersatz für Erste-Hilfe-Kurs oder ärztliche Beratung.

D = Expertenstandard (DNQP, 2022) · W = Weltleitlinie (Montero-Odasso et al., 2022) · P = Praxishinweis, nicht einzeln belegt. Quellenverzeichnis im Beitrag auf pflegelaborblog.de.

BLATT 2 VON 4 · WOHNUNG-CHECK

Gefahren erkennen, bevor etwas passiert

Gehe die Räume gemeinsam mit der betroffenen Person durch. Kleine Anpassungen reichen oft.

Wohnung / Zimmer: _____ Datum: _____

Flur und Wege

- ☐ Laufwege sind frei, keine Möbel oder Pflanzen im Weg. P
- ☐ Kabel liegen nicht auf dem Boden. P
- ☐ Teppiche und Läufer sind am Boden befestigt oder entfernt, Kanten stehen nicht hoch. P
- ☐ Schwellen und Stufen sind auffällig markiert. P
- ☐ Bei Rollator oder Rollstuhl: genug Platz zum Drehen und Durchfahren. P

Licht

- ☐ Alle Wege sind ausreichend hell. P
- ☐ Für die Nacht: Lampen mit Bewegungsmelder oder ein Nachtlicht auf dem Weg zur Toilette. P

Bad und Toilette

- ☐ Rutschfeste Matte in Dusche oder Wanne und vor dem Waschbecken. P
- ☐ Haltegriffe an Toilette und Dusche angebracht (oder geplant). P

Schlafzimmer, Treppe, Küche

- ☐ Am Bett: Licht vom Bett aus erreichbar, Platz zum sicheren Aufstehen. P
- ☐ Treppe: Handlauf vorhanden, Stufen gut erkennbar. P
- ☐ Häufig genutzte Dinge liegen in Griffhöhe, ohne Leiter oder Stuhl. P

Hilfe holen können

- ☐ Telefon oder Hausnotruf ist vom Boden aus erreichbar, auch nachts. P

Einordnung: Die Weltleitlinie empfiehlt, dass eine dafür ausgebildete Fachperson Gefahren in der Wohnumgebung einer Person erkennt (Montero-Odasso et al., 2022, S. 17; Empfehlungsgrad 1B). Welche einzelnen Maßnahmen wirken, ist damit nicht für jeden Punkt dieser Liste belegt. Die Punkte sind Beispiele aus der Praxis. Der Expertenstandard sieht eine individuelle Umgebungsanpassung und geeignete Hilfsmittel vor (DNQP, 2022, S. 23).

Information und Bildung, kein geprüftes Messinstrument, keine Pflegeberatung (§ 7a SGB XI), kein Ersatz für Erste-Hilfe-Kurs oder ärztliche Beratung.

D = Expertenstandard (DNQP, 2022) · W = Weltleitlinie (Montero-Odasso et al., 2022) · P = Praxishinweis, nicht einzeln belegt. Quellenverzeichnis im Beitrag auf pflegelaborblog.de.

BLATT 3 VON 4 · ABLAUFKARTE

Nach einem Sturz: So gehe ich vor

Zum Aufhängen oder Einstecken. Im Zweifel immer den Notruf 112 wählen.

1 Ansprechen und Lage ansehen

- Ruhe bewahren, ansprechen. Nicht sofort hochziehen oder aufrichten. P
- Reagiert sie? Atmet sie normal? P

2 Nicht ansprechbar

- Atmung prüfen. Atmet sie normal: stabile Seitenlage und Notruf 112. P
- Atmet sie nicht normal: Notruf 112 und Wiederbelebung, wie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. P

3 Verdacht auf eine Verletzung

- Hüfte oder Bein: nicht mehr aufstehen lassen, möglichst schmerzfreie Lage, Notruf 112. P
- Offener Bruch: keimfreie Wundauflage ohne Druck auflegen, Notruf 112. P
- Arm oder Hand: mit einem Dreiecktuch ruhigstellen, Notruf 112. P

4 Ansprechbar, keine erkennbare Verletzung

- Fragen: Was ist passiert? Vorher schon gestürzt? Kurz weggetreten oder schwindelig gewesen? Wie sicher ist das Gehen sonst? W
- Erst aufstehen helfen, wenn keine Schmerzen da sind und die Person sich sicher fühlt. Langsam, mit Unterstützung. Im Zweifel liegen lassen und Hilfe holen. P

5 Hilfe und Information

- Ärztin oder Arzt informieren bei Verletzung, Schmerzen, Schwindel, Bewusstseinsverlust oder wenn du unsicher bist. P
- Konnte die Person nicht allein aufstehen und lag mindestens eine Stunde am Boden? Ärztlich besprechen. Die Leitlinie wertet das als Hinweis auf hohes Sturzrisiko. W
- Angehörige informieren, in Einrichtungen nach dem Verfahren des Hauses. D P

6 Danach

- Den Sturz aufschreiben (Blatt 4). Jeder Sturz wird dokumentiert und analysiert. D
- Risiko neu einschätzen, Maßnahmenplan anpassen. D W
- Über die Angst vor dem nächsten Sturz sprechen (mögliche Folge: Verlust des Vertrauens in die eigene Mobilität). D

Wichtige Nummern

Hausarzt: _____ Pflege: _____

Angehörige: _____ Sonstige: _____

Die Erste-Hilfe-Schritte sind Grundsätze aus der Ausbildung, keine Leitlinienaussage. Die Weltleitlinie behandelt die Versorgung von Sturzverletzungen ausdrücklich nicht. Information und Bildung, kein geprüftes Messinstrument, keine Pflegeberatung (§ 7a SGB XI), kein Ersatz für Erste-Hilfe-Kurs oder ärztliche Beratung.

D = Expertenstandard (DNQP, 2022) · W = Weltleitlinie (Montero-Odasso et al., 2022) · P = Praxishinweis, nicht einzeln belegt. Quellenverzeichnis im Beitrag auf pflegelaborblog.de.

BLATT 4 VON 4 · STURZPROTOKOLL

Jeden Sturz festhalten

Damit Häufigkeit, Umstände und Folgen sichtbar werden und die Maßnahmen angepasst werden können.

Person (Kürzel): _____ Datum, Uhrzeit: _____

Ort: _____ Gefunden von: _____

Umstände

Was tat die Person gerade? _____

Schuhe / Hilfsmittel / Licht: _____

□ Schwindel vorher □ Kurz bewusstlos □ Nichts davon bekannt

Folgen

□ keine Verletzung □ Schmerzen □ Prellung / Wunde

□ Verdacht auf Bruch □ Kopf angestoßen □ Angst vor erneutem Sturz

Liegedauer am Boden: _____

Allein aufstehen? Ja / nein: _____

Was wurde getan?

□ Notruf 112 □ Arzt informiert □ Angehörige informiert

Wann / wer: _____

Auswertung

Stürze in 12 Monaten: _____

Mögliche Ursachen: _____

Was ändern wir? _____

_____

□ Risiko neu eingeschätzt □ Maßnahmenplan angepasst

Der Expertenstandard verlangt, jeden Sturz zu dokumentieren und zu analysieren, gegebenenfalls mit anderen beteiligten Berufsgruppen (DNQP, 2022, S. 23). Die Fragen nach Ablauf, früheren Stürzen, Schwindel und Bewusstseinsverlust folgen einer Expertenempfehlung der Weltleitlinie (Montero-Odasso et al., 2022, S. 8). In Einrichtungen gilt das Verfahren des Hauses. Bewahre ausgefüllte Blätter vertraulich auf. Information und Bildung, kein geprüftes Messinstrument, keine Pflegeberatung (§ 7a SGB XI), kein Ersatz für Erste-Hilfe-Kurs oder ärztliche Beratung.

D = Expertenstandard (DNQP, 2022) · W = Weltleitlinie (Montero-Odasso et al., 2022) · P = Praxishinweis, nicht einzeln belegt. Quellenverzeichnis im Beitrag auf pflegelaborblog.de.